

Патологогістологічне дослідження № 14268

Заклад	КНП "Золочівська центральна районна лікарня", ендоск.	Клінічні дані
ПІБ пацієнта	Маленький Богдан	Дата отримання матеріалу 11.06.2025
Вік	1963 р.н.	Біопсія <u>первинна</u> , вторинна (підкреслити)
Стать	Чол.	При вторинній біопсії вказати номер і дату первинної
Телефон замовника		Біопсія діагностична
Лікуючий лікар	Грицьків М. В.	Дата і вид операції 06.06.2025 Колоноскопія.
Клінічний діагноз	Виразковий проктит.	

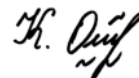
Дані про патологогістологічне дослідження

Маркування матеріалу, кількість об'єктів	1. 2 шматки слизової з меж купола сліпої кишки, 2.4шматки слизової з дистальної третини ампули прямої кишки.
Нумерація гістологічних блоків	54863-54867
Кількість блоків	5
Метод забарвлення	Гематоксилін/еозин
Макро і -мікроскопічний опис	№1. 2 біоптати слизової сліпої кишки, взяті до м'язової пластинки слизової. Слизова товстої кишки витончена, з дифузною помірною інфільтрацією плазматичними клітинами, лімфоцитами, еозинофільними та поодинокими нейтрофільними гранулоцитами в стромі; архітектоніка крипт збережена. №2. 3 біоптати слизової прямої кишки, взяті до м'язової пластинки слизової. Слизова прямої кишки з ділянками ерозуювання, дифузною вираженою інфільтрацією плазматичними клітинами, лімфоцитами, нейтрофільними та еозинофільними гранулоцитами в стромі та м'язовій пластинці слизової; архітектоніка крипт порушена, вогнищева атрофія крипт.
Патологогістологічний висновок (діагноз)	В біоптатах слизової товстої кишки морфологічна картина відповідає хронічному активному запальному захворюванню кишківника. За відповідної клінічної картини, гістологічна картина може відповідати неспецифічному виразковому коліту.
Категорія складності	IV Категорія складності
Архівування вологого матеріалу	ні

Лікар-патологоанатом:

Бевза Д. П.
+380978638955

Лаборант:



Кальчун О. Б.

Завідувач
гістологічної
лабораторії:Міщенко К.С.
+380681475411

Дата виконання: 13.06.2025

ФСУ - 7.4.010

Редакція 1 від 06.01.2025

Сторінки 1 з 1